LAPORAN PENDAHULUAN DAN ASUHAN KEPERAWATAN GAWAT DARURAT PADA Tn. S DENGAN CVA INFARK DI IGD RST Tk. II Dr. SOEPRAOEN

Dibuat untuk Memenuhi Tugas Praktik Klinik Keperawatan Gawat Darurat

Pembimbing Institusi : Sulastyawati, S.Kep., Ns., M.Kep.

Disusun Oleh:

Resti Novita Sari (P17210241040)

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG

JURUSAN KEPERAWATAN D- III KEPERAWATAN MALANG

2026

LAPORAN PENDAHULUAN DAN ASUHAN KEPERAWATAN GAWAT DARURAT PADA Tn. S DENGAN CVA INFARK DI IGD RST Tk. II Dr. SOEPRAOEN

Laporan Ini Telah Memenuhi Persyaratan Praktik Klinik Keperawatan Gawat Darurat

Program Studi D-III Keperawatan Malang

Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Malang

Malang, Oktober 2026

Mahasiswa

RESTI NOVITA SARI

(P17210241040)

Mengetahui,

Pembimbing Institusi	**Pembimbing Lahan**
Sulastyawati, S.Kep., Ns., M.Kep.	Wisudah, S.Kep., Ners
NIP: 197811302005012002	**NIP. 197607032014102001**

Kepala Ruang

Moh. Samsul H, S.Kep., Ners

NIP. 197706031997031001

LAPORAN PENDAHULUAN

1. KONSEP DASAR

1.1 Pengertian

Cerebrovascular accident (CVA) infark atau stroke iskemik adalah gangguan neurologis fokal yang timbul mendadak akibat terhentinya aliran darah ke sebagian jaringan otak karena sumbatan pembuluh darah arteri, sehingga jaringan tersebut mengalami infark. Kondisi ini berbeda dengan stroke hemoragik yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah (Hui et al., 2024). Stroke iskemik merupakan jenis yang paling sering ditemukan, yaitu sekitar 62% dari seluruh kejadian stroke baru di dunia (Feigin et al., 2021).

Stroke merupakan penyebab kematian kedua terbanyak dan penyebab ketiga terbanyak kematian dan disabilitas secara gabungan di dunia (Feigin et al., 2021). Sebagian besar beban stroke berada di negara berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk akses yang terbatas terhadap terapi reperfusi akut (Saini et al., 2021; Feigin et al., 2022). Karena jaringan otak sangat cepat rusak bila kekurangan aliran darah, stroke iskemik dipandang sebagai kegawatdaruratan yang sangat bergantung pada waktu (*time is brain*), sehingga pengenalan dini dan penanganan cepat di IGD menentukan luaran pasien (Berge et al., 2021).

1.2 Etiologi

Stroke iskemik terjadi akibat oklusi arteri serebral yang dapat disebabkan oleh beberapa mekanisme berikut (Hui et al., 2024; Hilkens et al., 2024):

1) Trombosis pada aterosklerosis arteri besar, yaitu pembentukan trombus pada plak aterosklerotik di arteri karotis, arteri serebri, atau sistem vertebrobasilar.
2) Emboli kardiogenik, yaitu bekuan darah dari jantung yang terlepas dan menyumbat arteri otak, terutama pada fibrilasi atrium, penyakit katup jantung, dan infark miokard.
3) Penyakit pembuluh darah kecil (lakunar), yaitu oklusi arteri kecil yang berkaitan dengan hipertensi dan diabetes melitus kronis.
4) Penyebab lain, misalnya diseksi arteri, koagulopati, vaskulitis, dan penyebab yang belum dapat ditentukan.

Faktor risiko yang dapat dimodifikasi meliputi hipertensi, diabetes melitus, dislipidemia, fibrilasi atrium, merokok, obesitas, dan kurangnya aktivitas fisik. Faktor yang tidak dapat dimodifikasi meliputi usia lanjut, jenis kelamin, dan riwayat keluarga (Kleindorfer

et al., 2021). Hipertensi merupakan faktor risiko terpenting dan paling sering ditemukan pada pasien stroke (Hui et al., 2024).

1.3 Klasifikasi

Stroke iskemik dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa pendekatan (Hui et al., 2024):

1) Berdasarkan mekanisme/etiologi (klasifikasi TOAST), yaitu aterosklerosis arteri besar, kardioemboli, oklusi pembuluh kecil (lakunar), stroke dengan etiologi lain yang telah ditentukan, dan stroke dengan etiologi tidak diketahui.
2) Berdasarkan wilayah vaskular, yaitu sirkulasi anterior (arteri karotis interna, serebri anterior, dan serebri media) dan sirkulasi posterior (sistem vertebrobasilar).
3) Berdasarkan durasi gejala, yaitu *transient ischemic attack* (TIA) bila gejala menghilang sempurna tanpa bukti infark pada pencitraan, dan stroke iskemik bila defisit menetap disertai infark.
4) Berdasarkan derajat keparahan, dinilai dengan *National Institutes of Health Stroke Scale* (NIHSS) dengan rentang 0–42: 0 (tidak ada gejala), 1–4 (ringan), 5–15 (sedang), 16–20 (sedang-berat), dan 21–42 (berat) (Hui et al., 2024).

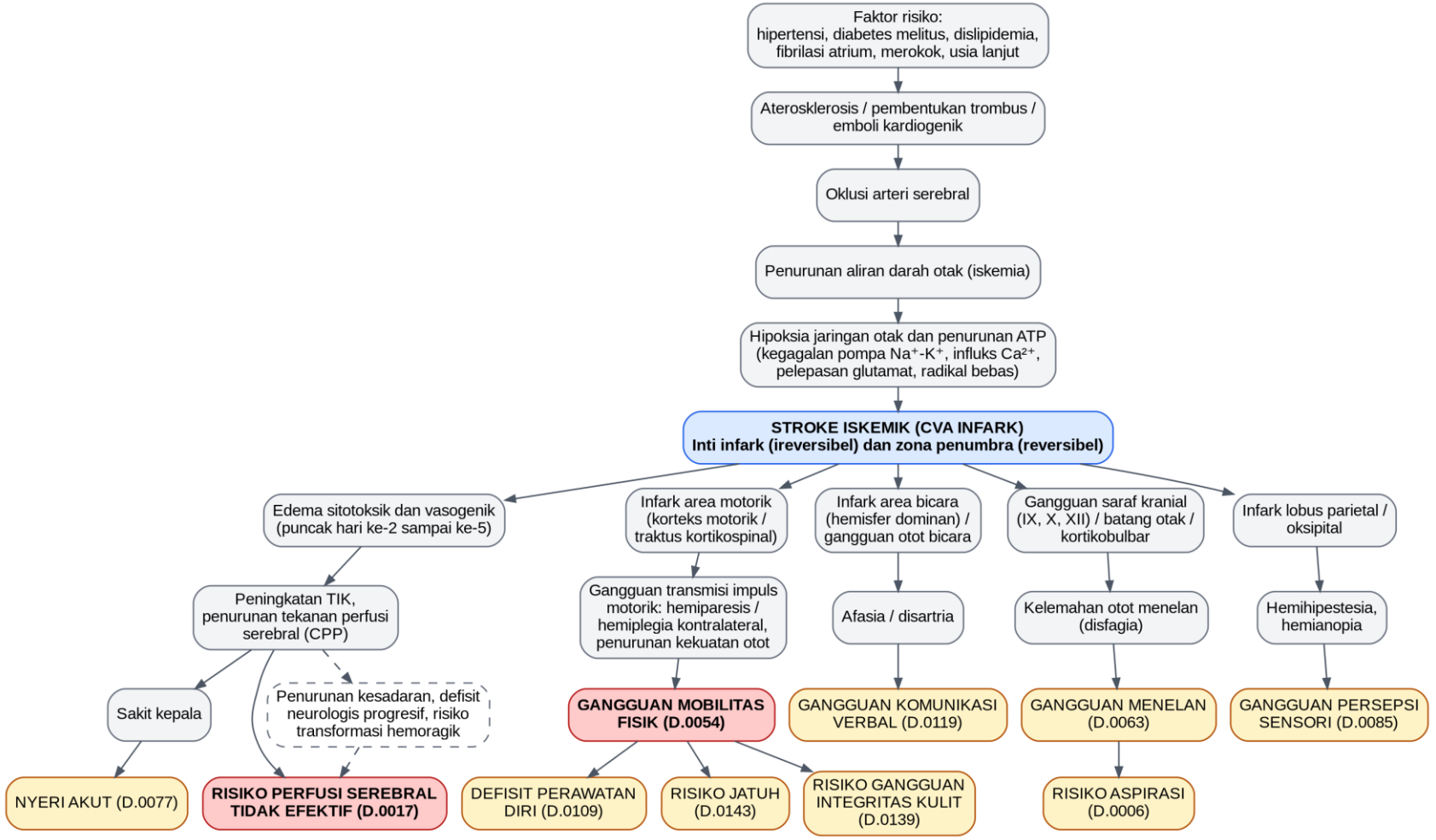
1.4 Patofisiologi

Sumbatan arteri serebral menurunkan aliran darah otak di wilayah yang dialirinya. Area yang aliran darahnya turun berat membentuk inti infark yang mengalami kematian sel ireversibel dalam waktu singkat, sedangkan area di sekelilingnya yang masih mendapat aliran kolateral disebut zona penumbra, yaitu jaringan yang fungsinya terganggu tetapi masih dapat diselamatkan bila aliran darah segera dipulihkan (Hui et al., 2024; Hilkens et al., 2024).

Kekurangan oksigen dan glukosa menyebabkan produksi *adenosine triphosphate* (ATP) menurun sehingga pompa Na^+-K^+ gagal, terjadi depolarisasi membran, masuknya kalsium ke dalam sel, dan pelepasan glutamat berlebihan (eksitotoksisitas). Proses ini diikuti pembentukan radikal bebas, aktivasi enzim perusak sel, dan kematian sel neuron melalui nekrosis maupun apoptosis (Hui et al., 2024). Masuknya air ke dalam sel menimbulkan edema sitotoksik, yang kemudian disusul edema vasogenik akibat kerusakan sawar darah otak. Edema mencapai puncak pada hari ke-2 sampai ke-5 dan dapat meningkatkan tekanan intrakranial (TIK), menurunkan tekanan perfusi serebral, dan pada kasus berat menyebabkan herniasi (Hilkens et al., 2024).

Pada area motorik (korteks motorik dan traktus kortikospinal), kerusakan neuron menyebabkan gangguan penghantaran impuls ke otot sehingga timbul kelemahan atau kelumpuhan separuh tubuh di sisi yang berlawanan dengan lokasi lesi (hemiparesis/hemiplegia) (Hui et al., 2024). Selain itu, kerusakan pada area bicara, saraf kranial, dan area sensorik menimbulkan gangguan komunikasi, menelan, dan persepsi sensori. Ancaman terhadap perfusi otak dan gangguan fungsi motorik menjadi dasar diagnosis prioritas yang difokuskan intervensinya pada laporan ini.

1.5 Pathway



Disusun dari Hui et al. (2024); Hilkens et al. (2024); Kleindorfer et al. (2021); kode diagnosis mengacu pada SDKI (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017). Kotak merah muda = diagnosis prioritas (fokus intervensi); kotak kuning = diagnosis lain yang dapat muncul; kotak putus-putus = kondisi yang dapat menyertai.

1.6 Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis bergantung pada wilayah otak yang mengalami infark. Gejala yang khas muncul mendadak dan dikenali dengan singkatan *BE-FAST*, yaitu gangguan keseimbangan (*balance*), gangguan penglihatan (*eyes*), wajah mencong (*face drooping*), kelemahan lengan atau tungkai (*arm weakness*), bicara pelo atau sulit berbicara (*speech difficulty*), dan waktu (*time*) untuk segera mencari pertolongan (Hui et al., 2024).

1) Arteri serebri media: hemiparesis atau hemiplegia kontralateral (lengan dan wajah lebih berat daripada tungkai), hemihipestesia, afasia bila mengenai hemisfer dominan, dan deviasi pandangan ke arah lesi (Hui et al., 2024).
2) Arteri serebri anterior: kelemahan tungkai kontralateral lebih berat daripada lengan, perubahan perilaku, dan inkontinensia (Hui et al., 2024).
3) Arteri serebri posterior: gangguan lapang pandang (hemianopia homonim), gangguan penglihatan, dan gangguan memori (Hui et al., 2024).
4) Sistem vertebrobasilar: vertigo, ataksia, diplopia, disartria, disfagia, mual muntah, dan penurunan kesadaran (Hilkens et al., 2024).

Gejala lain yang dapat menyertai adalah sakit kepala, penurunan kesadaran, kejang, dan gangguan menelan (disfagia) (Hilkens et al., 2024; Dziewas et al., 2021).

1.7 Pemeriksaan Penunjang

1) CT scan kepala tanpa kontras merupakan pemeriksaan pencitraan pertama yang harus dilakukan segera untuk menyingkirkan perdarahan intrakranial sebelum terapi reperfusi (Berge et al., 2021).
2) CT angiografi/MR angiografi dan MRI difusi (DWI) digunakan untuk mengidentifikasi oklusi pembuluh darah besar, menilai inti infark dan jaringan penumbra, serta menentukan kandidat trombektomi mekanik (Turc et al., 2023; Hui et al., 2024).
3) Glukosa darah sewaktu dilakukan segera karena hipoglikemia dapat menyerupai stroke (Hui et al., 2024).
4) Elektrokardiogram (EKG) untuk mendeteksi fibrilasi atrium dan iskemia miokard sebagai sumber emboli (Kleindorfer et al., 2021).
5) Pemeriksaan laboratorium: darah lengkap, elektrolit, ureum dan kreatinin, profil lipid, waktu protrombin (PT/INR), aPTT, dan troponin (Hui et al., 2024).

Pemeriksaan penunjang tidak boleh menunda penanganan awal, dan pemeriksaan neurologis yang teliti tetap menjadi dasar penilaian (Berge et al., 2021).

1.8 Penatalaksanaan Medis

Penanganan di IGD diarahkan untuk menstabilkan kondisi pasien dengan prinsip ABCDE, memastikan waktu awitan gejala (*last known well*), dan menentukan kelayakan terapi reperfusi secepat mungkin (Hui et al., 2024; Berge et al., 2021).

1) Stabilisasi umum. Pertahankan jalan napas dan oksigenasi, dengan pemberian oksigen bila saturasi di bawah 94%. Pantau tekanan darah, glukosa darah, dan suhu. Hipoglikemia dikoreksi, hiperglikemia dikendalikan, dan demam diatasi (Hui et al., 2024).
2) Trombolisis intravena. Alteplase (0,9 mg/kgBB, maksimal 90 mg) dapat diberikan pada pasien yang memenuhi kriteria dalam 4,5 jam sejak awitan gejala setelah perdarahan disingkirkan dengan CT scan. Tekanan darah harus di bawah 185/110 mmHg sebelum pemberian (Berge et al., 2021).
3) Trombektomi mekanik dipertimbangkan pada oklusi pembuluh darah besar dengan seleksi pencitraan yang sesuai, baik dikombinasikan dengan trombolisis maupun tanpa trombolisis (Turc et al., 2023).
4) Terapi antitrombotik. Antiplatelet (mis. aspirin) diberikan setelah perdarahan disingkirkan, pada pasien yang tidak menerima trombolisis. Bila diberikan trombolisis, antiplatelet ditunda minimal 24 jam dan setelah CT ulang tidak menunjukkan perdarahan (Hui et al., 2024).
5) Pengelolaan tekanan darah. Pada pasien yang tidak menerima terapi reperfusi, tekanan darah yang tinggi tidak diturunkan secara agresif pada fase awal kecuali sangat tinggi atau terdapat indikasi lain, karena penurunan tekanan darah yang berlebihan dapat memperburuk perfusi pada zona penumbra (Hui et al., 2024).
6) Terapi penyerta. Statin, pengendalian edema serebral dan TIK (posisi kepala, osmoterapi bila perlu), antikonvulsan bila terjadi kejang, serta profilaksis tromboemboli vena (Hui et al., 2024).
7) Skrining disfagia. Pasien tidak boleh diberi makanan atau minuman per oral sebelum skrining menelan dilakukan, untuk mencegah pneumonia aspirasi (Dziewas et al., 2021).

8) Rujukan dan rehabilitasi. Pasien yang memerlukan fasilitas *stroke unit*, neurointervensi, atau perawatan intensif perlu dirujuk bila tidak tersedia di rumah sakit. Rehabilitasi dini dimulai setelah kondisi stabil (Hui et al., 2024).

1.9 Komplikasi

Komplikasi yang dapat timbul akibat CVA Infark meliputi edema serebral dan peningkatan tekanan intrakranial (TIK), terutama pada infark luas dengan risiko terjadinya herniasi (Hilkens et al., 2024). Selain itu, pasien berisiko mengalami transformasi hemoragik pada area infark, khususnya setelah pemberian terapi trombolisis (Berge et al., 2021), serta dapat disertai kejang dan penurunan kesadaran (Hui et al., 2024). Kondisi disfagia pada pasien juga berpotensi memicu timbulnya pneumonia aspirasi (Dziewas et al., 2021). Dampak imobilitas fisik dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan komplikasi sekunder berupa trombosis vena dalam, emboli paru, ulkus dekubitus, kontraktur, serta nyeri bahu hemiplegik (Hui et al., 2024). Beberapa komplikasi sistemik dan jangka panjang lainnya yang perlu diwaspadai mencakup infeksi saluran kemih, depresi pascastroke, hingga risiko serangan stroke berulang (Hui et al., 2024; Kleindorfer et al., 2021).

2. KONSEP ASUHAN KEPERAWATAN GAWAT DARURAT

2.1 Pengkajian

a. Identitas

Identitas pasien meliputi nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, nomor rekam medis, tanggal dan jam masuk IGD, sumber informasi, serta diagnosis medis. Risiko stroke meningkat seiring pertambahan usia, terutama setelah usia 55 tahun (Hui et al., 2024). Perawat juga perlu mencatat waktu awitan gejala dan cara datang pasien, karena informasi ini menentukan kelayakan terapi reperfusi (Berge et al., 2021).

b. Triase

Triase adalah proses menentukan prioritas penanganan pasien berdasarkan tingkat kegawatan. Triase merupakan keputusan cepat yang dibuat perawat untuk menetapkan urgensi dan dianggap sebagai salah satu peran keperawatan paling penting di IGD, yang menuntut kemampuan berpikir kritis, pengkajian, dan komunikasi (Butler et al., 2023).

Pada pasien dengan kecurigaan stroke akut, triase mencakup deteksi cepat tanda stroke (BE-FAST), penilaian jalan napas, kesadaran, dan tanda vital, serta pencatatan waktu *last known well*. Pasien dengan stroke akut harus diprioritaskan karena terapi reperfusi sangat bergantung pada waktu, sehingga pasien perlu segera dilaporkan kepada dokter dan dilakukan CT scan kepala (Berge et al., 2021; Hui et al., 2024).

c. *Primary survey*

Primary survey dilakukan dengan pendekatan ABCDE, yaitu *airway*, *breathing*, *circulation*, *disability*, dan *exposure*, untuk mengidentifikasi dan menangani kondisi yang mengancam nyawa terlebih dahulu (Hui et al., 2024).

1) Airway (Jalan Napas)

Dikaji kepatenan jalan napas, kemampuan berbicara, suara napas tambahan (*gurgling*, mengorok, stridor), lidah jatuh, sekret atau muntahan, serta kemampuan menelan. Pasien stroke berisiko mengalami sumbatan jalan napas akibat penurunan kesadaran dan gangguan refleks menelan (Hui et al., 2024; Dziewas et al., 2021).

2) Breathing (Pernapasan)

Dikaji frekuensi, irama, kedalaman, dan pola napas, saturasi oksigen, penggunaan otot bantu napas, serta suara napas pada kedua paru. Pola napas ireguler (mis. Cheyne-Stokes) dapat menandakan peningkatan TIK. Oksigen diberikan bila saturasi di bawah 94% (Hui et al., 2024).

3) Circulation (Sirkulasi)

Dikaji tekanan darah, frekuensi dan irama nadi, warna dan suhu kulit, serta *capillary refill time* (CRT). Nadi yang tidak teratur dapat menandakan fibrilasi atrium sebagai sumber emboli, sehingga EKG perlu dilakukan. Tekanan darah dipantau karena menentukan keputusan terapi reperfusi (Berge et al., 2021; Kleindorfer et al., 2021).

4) Disability

Dikaji tingkat kesadaran dengan *Glasgow Coma Scale* (GCS), ukuran dan reaksi pupil, kekuatan motorik dan sensorik, serta tanda stroke dengan BE-FAST atau skor NIHSS. Glukosa darah sewaktu diperiksa segera untuk

menyingkirkan hipoglikemia. Penurunan kesadaran, perubahan pupil, dan peningkatan tekanan darah disertai bradikardia dapat menandakan peningkatan TIK (Hui et al., 2024; Hilkens et al., 2024).

5) Exposure

Pakaian pasien dibuka untuk memeriksa seluruh tubuh dan menemukan cedera akibat jatuh saat awitan, dengan tetap menjaga privasi dan mencegah hipotermia. Suhu tubuh diperiksa karena demam memperburuk luaran stroke (Hui et al., 2024).

d. *Secondary Survey*

Secondary survey dilakukan setelah *primary survey* selesai dan kondisi yang mengancam nyawa sudah tertangani, berupa anamnesis dan pemeriksaan fisik yang lebih rinci (Hui et al., 2024).

1) Keluhan utama

Keluhan utama dikaji berdasarkan pernyataan pasien atau keluarga, yang umumnya berupa kelemahan separuh badan, bicara pelo, wajah mencong, sulit berbicara, sakit kepala, atau penurunan kesadaran (Hui et al., 2024).

2) Riwayat kejadian

Dikaji kapan gejala pertama muncul atau terakhir kali pasien terlihat normal (*last known well*), apakah gejala muncul saat beraktivitas atau saat bangun tidur, perkembangan gejala, adanya kejang, muntah, atau trauma kepala, serta tindakan yang telah dilakukan sebelum ke IGD (Berge et al., 2021).

e. Pengkajian SAMPLE

1) S – *Sign and Symptoms*

Tanda dan gejala yang dirasakan, seperti kelemahan sisi tubuh, wajah mencong, bicara pelo, gangguan penglihatan, vertigo, sakit kepala, mual muntah, dan gangguan menelan (Hui et al., 2024).

2) A – *Allergies*

Riwayat alergi obat, makanan, atau zat lain, terutama terhadap obat yang akan diberikan di IGD, misalnya kontras pencitraan (Hui et al., 2024).

3) M – *Medications*

Obat yang sedang dikonsumsi, terutama antikoagulan, antiplatelet, antihipertensi, dan antidiabetik. Penggunaan antikoagulan memengaruhi kelayakan trombolisis (Berge et al., 2021).

4) P – *Past History*

Riwayat hipertensi, diabetes melitus, dislipidemia, fibrilasi atrium atau penyakit jantung, stroke atau TIA sebelumnya, serta kebiasaan merokok (Kleindorfer et al., 2021; Hui et al., 2024).

5) L – *Last Meal*

Waktu dan jenis makanan atau minuman terakhir. Pasien dipuasakan sampai skrining menelan dilakukan untuk mencegah aspirasi (Dziewas et al., 2021).

6) E – *Event*

Kronologi kejadian secara sistematis: kapan gejala muncul, aktivitas saat gejala muncul, bagaimana perkembangan gejala, serta ada tidaknya pingsan, kejang, muntah, atau jatuh (Berge et al., 2021).

f. Tanda-Tanda Vital

Meliputi tekanan darah, frekuensi nadi, suhu tubuh, frekuensi pernapasan, dan saturasi oksigen. Hipertensi sering ditemukan pada fase akut stroke. Peningkatan tekanan darah disertai bradikardia dan napas ireguler (trias Cushing) menandakan peningkatan TIK. Demam dan perubahan saturasi oksigen juga perlu dipantau (Hui et al., 2024).

g. Pengkajian Nyeri

Pengkajian nyeri menggunakan pendekatan PQRST. Pada stroke, nyeri yang sering muncul adalah sakit kepala dan nyeri bahu pada sisi yang lemah.

1) P (*Provocation/Palliation*): faktor yang memperberat atau meringankan nyeri, misalnya perubahan posisi atau gerakan.

2) Q (*Quality*): kualitas nyeri, seperti berdenyut, tertekan, atau tertusuk.

3) R (*Region/Radiation*): lokasi dan penyebaran nyeri, misalnya kepala atau bahu sisi yang lemah.

4) S (*Severity*): tingkat keparahan nyeri menggunakan *Numeric Rating Scale* 0–10.

5) T (*Time*): waktu mulai, lama, dan frekuensi nyeri.

h. Pemeriksaan Fisik *Head-to-Toe*

Pemeriksaan dilakukan secara sistematis dengan pendekatan DCAPBTLS (*deformity, contusion, abrasion, penetration, burns, tenderness, laceration, swelling*) untuk mengidentifikasi cedera akibat jatuh dan menilai status neurologis.

1) Kepala

Inspeksi dan palpasi untuk menilai trauma kepala, kesimetrisan wajah (wajah mencong/*facial droop*), dan kemampuan menyeringai. Dinilai pula bicara (pelo atau afasia).

2) Mata

Ukuran dan reaksi pupil, deviasi pandangan, lapang pandang, gerakan bola mata, dan diplopia.

3) Leher

Kaku kuduk, distensi vena jugularis, bruit karotis, dan nyeri tekan atau cedera servikal bila ada riwayat jatuh.

4) Bahu

Deformitas, nyeri tekan, dan pergerakan bahu, terutama pada sisi yang lemah (risiko subluksasi bahu).

5) Dada

Inspeksi kesimetrisan gerakan dada, palpasi, perkusi, dan auskultasi suara napas (ronkhi menandakan sekret atau aspirasi) serta bunyi jantung (irama ireguler).

6) Abdomen

Distensi, bising usus, nyeri tekan, dan retensi urine pada kandung kemih.

7) Genitalia

Dikaji sesuai indikasi, termasuk inkontinensia urine atau alvi.

8) Punggung

Deformitas, memar, luka, dan nyeri tekan; periksa area tekanan.

9) Panggul

Deformitas, nyeri tekan, dan stabilitas panggul.

10) Ekstremitas

Kekuatan otot (skala 0–5), tonus, refleks fisiologis dan patologis (Babinski), sensorik, rentang gerak (ROM), warna dan suhu kulit, CRT, serta edema. Dibandingkan sisi kanan dan kiri (Hui et al., 2024).

2.2 Diagnosa

Berdasarkan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), diagnosis keperawatan yang dapat muncul pada pasien stroke iskemik di IGD sesuai pathway adalah (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017):

1) Risiko perfusi serebral tidak efektif **(D.0017)** dibuktikan dengan faktor risiko hipertensi, aterosklerosis, embolisme, dan fibrilasi atrium.
2) Gangguan mobilitas fisik **(D.0054)** berhubungan dengan gangguan neuromuskular (infark area motorik) dan penurunan kekuatan otot dibuktikan dengan mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas, kekuatan otot menurun, dan rentang gerak (ROM) menurun.
3) Gangguan komunikasi verbal **(D.0119)** berhubungan dengan penurunan sirkulasi serebral dibuktikan dengan bicara pelo, afasia atau disartria, dan sulit mengungkapkan kata-kata.
4) Gangguan menelan **(D.0063)** berhubungan dengan gangguan saraf kranial dan gangguan serebrovaskular dibuktikan dengan mengeluh sulit menelan, batuk atau tersedak saat menelan, dan makanan tertinggal di rongga mulut.
5) Risiko aspirasi **(D.0006)** dibuktikan dengan faktor risiko gangguan menelan, penurunan tingkat kesadaran, dan penurunan refleks batuk.
6) Nyeri akut **(D.0077)** berhubungan dengan agen pencedera fisiologis (peningkatan tekanan intrakranial/edema serebral) dibuktikan dengan mengeluh nyeri kepala, tampak meringis, dan gelisah.
7) Defisit perawatan diri **(D.0109)** berhubungan dengan kelemahan dan gangguan neuromuskular dibuktikan dengan tidak mampu mandi, berpakaian, makan, dan toileting secara mandiri.
8) Risiko jatuh **(D.0143)** dibuktikan dengan faktor risiko penurunan kekuatan ekstremitas bawah, gangguan keseimbangan, dan gangguan penglihatan.

9) Risiko gangguan integritas kulit/jaringan **(D.0139)** dibuktikan dengan faktor risiko penurunan mobilitas (tirah baring), perubahan sirkulasi, dan penekanan pada tonjolan tulang.

10) Gangguan persepsi sensori **(D.0085)** berhubungan dengan gangguan penglihatan dan gangguan perabaan dibuktikan dengan distorsi sensori (hemianopia/hemihipestesia) dan respons tidak sesuai.

2.3 Intervensi

Tujuan dan kriteria hasil disusun berdasarkan Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI), sedangkan intervensi mengacu pada Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2019; Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018). Intervensi difokuskan pada dua diagnosa prioritas, yaitu risiko perfusi serebral tidak efektif dan gangguan mobilitas fisik, dan disajikan pada tabel berikut.

Diagnosa Keperawatan	Tujuan dan Kriteria Hasil	Intervensi Keperawatan	Rasional
Risiko perfusi serebral tidak efektif **(D.0017)** dibuktikan dengan faktor risiko hipertensi, aterosklerosis, embolisme, dan fibrilasi atrium	Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1x4 jam, maka perfusi serebral **(L.02014)** meningkat, dengan kriteria hasil: 1. tingkat kesadaran meningkat (5) 2. sakit kepala menurun (5) 3. gelisah menurun (5) 4. tekanan intrakranial menurun (5) 5. nilai rata-rata tekanan darah membaik (5) 6. tekanan darah sistolik membaik (5) 7. tekanan darah diastolik membaik (5) 8. refleks saraf membaik (5)	**Manajemen Peningkatan Tekanan Intrakranial (I.06194)** **Observasi** 1. Identifikasi penyebab peningkatan TIK (mis. lesi iskemik, edema serebral, gangguan metabolisme) 2. Monitor tanda/gejala peningkatan TIK (mis. tekanan darah meningkat, tekanan nadi melebar, bradikardia, pola napas ireguler, kesadaran menurun) 3. Monitor tingkat kesadaran (GCS), reaksi pupil, dan skor NIHSS secara berkala 4. Monitor tekanan darah, *Mean Arterial Pressure* (MAP), dan saturasi oksigen 5. Monitor status pernapasan 6. Monitor intake dan output cairan 7. Monitor kadar glukosa darah **Terapeutik** 1. Minimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang 2. Berikan posisi semi fowler (kepala tempat tidur 30°) dengan kepala dan leher dalam posisi netral 3. Hindari manuver Valsalva 4. Cegah terjadinya kejang 5. Hindari pemberian cairan IV hipotonik 6. Pertahankan suhu tubuh normal 7. Pasang akses intravena dan siapkan pasien untuk CT scan kepala sesuai instruksi dokter **Edukasi** 1. Jelaskan kondisi, tujuan pemantauan, dan tindakan yang dilakukan kepada pasien dan keluarga	**Manajemen Peningkatan Tekanan Intrakranial (I.06194)** **Observasi** 1. Menentukan penyebab agar penanganan tepat sasaran. 2. Mendeteksi dini peningkatan TIK; trias Cushing (hipertensi, bradikardia, napas ireguler) merupakan tanda lanjut yang mengancam nyawa. 3. Penurunan GCS, perubahan pupil, dan kenaikan skor NIHSS menandakan perburukan neurologis atau perluasan infark. 4. Menjaga tekanan perfusi serebral tetap adekuat; tekanan darah yang terlalu tinggi atau terlalu rendah memperburuk iskemia. 5. Mendeteksi hipoksia dan hipoventilasi yang memperberat iskemia otak. 6. Mencegah kelebihan cairan yang memperberat edema serebral. 7. Hipoglikemia dapat menyerupai stroke, sedangkan hiperglikemia memperburuk luaran neurologis. **Terapeutik** 1. Stimulasi berlebihan meningkatkan kebutuhan oksigen otak dan dapat menaikkan TIK. 2. Memfasilitasi drainase vena dari otak sehingga TIK menurun; leher yang fleksi atau rotasi menghambat aliran balik vena. 3. Valsalva meningkatkan tekanan intratorakal dan TIK. 4. Kejang meningkatkan metabolisme dan kebutuhan oksigen otak.

Diagnosa Keperawatan	Tujuan dan Kriteria Hasil	Intervensi Keperawatan	Rasional
		2. Anjurkan keluarga segera melapor bila terjadi penurunan kesadaran, nyeri kepala hebat, muntah proyektil, atau kelemahan bertambah **Kolaborasi** 1. Kolaborasi pemberian terapi reperfusi (trombolitik) atau antiplatelet sesuai indikasi 2. Kolaborasi pengendalian tekanan darah sesuai target (mis. <185/110 mmHg sebelum trombolisis; tidak diturunkan agresif bila tanpa terapi reperfusi) 3. Kolaborasi pemberian diuretik osmosis (mis. manitol) dan antikonvulsan, jika perlu	5. Cairan hipotonik memicu perpindahan air ke jaringan otak dan memperberat edema. 6. Demam meningkatkan metabolisme otak dan memperluas kerusakan jaringan penumbra. 7. Pencitraan dan reperfusi bersifat sangat bergantung waktu sehingga persiapan yang cepat memperpendek keterlambatan. **Edukasi** 1. Meningkatkan pemahaman dan kerja sama pasien serta keluarga. 2. Memungkinkan deteksi perburukan lebih awal oleh keluarga yang mendampingi. **Kolaborasi** 1. Reperfusi pada jendela waktu yang tepat menyelamatkan zona penumbra; antiplatelet mencegah pembentukan trombus baru. 2. Tekanan darah dijaga pada rentang yang aman agar perfusi tetap terjaga tanpa meningkatkan risiko perdarahan. 3. Menurunkan edema serebral dan mencegah kejang yang dapat memperburuk iskemia.
Gangguan mobilitas fisik **(D.0054)** berhubungan dengan gangguan neuromuskular (infark area motorik) dan penurunan kekuatan otot dibuktikan dengan kekuatan otot	Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1x4 jam, maka mobilitas fisik **(L.05042)** meningkat, dengan kriteria hasil: 1. pergerakan ekstremitas meningkat (5) 2. kekuatan otot meningkat (5)	**Dukungan Mobilisasi (I.05173)** **Observasi** 1. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya (mis. nyeri bahu pada sisi yang lemah) 2. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan 3. Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi 4. Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi	**Dukungan Mobilisasi (I.05173)** **Observasi** 1. Nyeri dapat membatasi pergerakan dan memengaruhi kemauan pasien untuk bergerak. 2. Menentukan batas aman aktivitas sesuai kemampuan pasien. 3. Mencegah fluktuasi hemodinamik yang dapat memperburuk perfusi otak saat bergerak.

Diagnosa Keperawatan	Tujuan dan Kriteria Hasil	Intervensi Keperawatan	Rasional
menurun, rentang gerak (ROM) menurun, dan sulit menggerakkan ekstremitas	3. rentang gerak (ROM) meningkat (5) 4. nyeri menurun (5) 5. kecemasan menurun (5) 6. gerakan terbatas menurun (5) 7. kelemahan fisik menurun (5)	5. Kaji kekuatan otot (skala 0–5) dan rentang gerak sendi pada keempat ekstremitas **Terapeutik** 1. Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu (mis. pagar tempat tidur) 2. Fasilitasi pergerakan: lakukan alih baring setiap 2 jam dan posisikan ekstremitas sisi lemah dalam posisi fungsional dengan penyangga 3. Pasang pagar pengaman tempat tidur dan letakkan bel dalam jangkauan untuk mencegah jatuh 4. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan **Edukasi** 1. Jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi 2. Anjurkan melakukan mobilisasi dini setelah kondisi neurologis dan hemodinamik stabil sesuai instruksi dokter 3. Ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan (mis. miring kanan-kiri, duduk di tempat tidur, latihan ROM pasif/aktif) **Kolaborasi** 1. Kolaborasi dengan dokter spesialis rehabilitasi medik/fisioterapis untuk program latihan	4. Mendeteksi intoleransi aktivitas atau perburukan neurologis lebih awal. 5. Menjadi data dasar untuk menilai kemajuan atau kemunduran kekuatan motorik. **Terapeutik** 1. Alat bantu memberi stabilitas dan rasa aman saat pasien bergerak. 2. Mengurangi tekanan lama pada kulit, mencegah dekubitus, kontraktur, dan nyeri bahu sisi lumpuh. 3. Pasien dengan kelemahan sebelah badan berisiko tinggi jatuh dan cedera. 4. Dukungan keluarga meningkatkan motivasi dan membantu kesinambungan latihan. **Edukasi** 1. Pemahaman pasien meningkatkan kepatuhan dan mengurangi kecemasan. 2. Mobilisasi dini mencegah komplikasi imobilitas (pneumonia, trombosis vena dalam), tetapi perlu menunggu kondisi stabil. 3. Latihan bertahap melatih kekuatan otot dan menjaga rentang gerak sendi. **Kolaborasi** 1. Program rehabilitasi terstruktur mempercepat pemulihan fungsi motorik.

2.4 Implementasi

Implementasi keperawatan merupakan tahap pelaksanaan tindakan keperawatan yang telah direncanakan berdasarkan diagnosis dan intervensi keperawatan. Implementasi dilakukan sesuai kondisi dan kebutuhan pasien, dengan memperhatikan prinsip keselamatan pasien serta respons pasien terhadap tindakan yang diberikan. Pada pasien stroke iskemik di IGD, implementasi mencakup:

1) Risiko perfusi serebral tidak efektif: memantau tingkat kesadaran (GCS), pupil, NIHSS, tanda-tanda vital, dan saturasi oksigen secara berkala; memposisikan semi fowler 30° dengan kepala-leher netral; menciptakan lingkungan yang tenang; memasang akses intravena; menyiapkan pasien untuk CT scan kepala; serta berkolaborasi dalam pemberian terapi reperfusi, antiplatelet, antihipertensi, atau terapi lain sesuai instruksi dokter.
2) Gangguan mobilitas fisik: mengkaji kekuatan otot dan ROM, melakukan alih baring setiap 2 jam, memposisikan ekstremitas sisi lemah secara fungsional, memasang pagar pengaman, melibatkan keluarga, mengajarkan latihan mobilisasi sederhana setelah kondisi stabil, serta berkolaborasi dengan rehabilitasi medik.

2.5 Evaluasi

Evaluasi keperawatan merupakan tahap untuk menilai respons pasien setelah dilakukan tindakan keperawatan serta mengetahui ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi pasien sebelum dan sesudah tindakan berdasarkan kriteria hasil yang telah ditentukan, misalnya:

1) Risiko perfusi serebral tidak efektif: tingkat kesadaran meningkat atau stabil, tidak ada peningkatan skor NIHSS, pupil isokor dan reaktif, sakit kepala menurun, serta tekanan darah dalam rentang target.
2) Gangguan mobilitas fisik: kekuatan otot dan rentang gerak meningkat atau tidak memburuk, pasien mampu melakukan latihan mobilisasi sederhana, serta tidak terjadi cedera akibat jatuh maupun luka tekan.

Hasil evaluasi dinyatakan sebagai masalah teratasi, teratasi sebagian, atau belum teratasi, sehingga rencana keperawatan dapat dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan sesuai kondisi pasien.

DAFTAR PUSTAKA

Berge, E., Whiteley, W., Audebert, H., De Marchis, G. M., Fonseca, A. C., Padiglioni, C., de la Ossa, N. P., Strbian, D., Tsivgoulis, G., & Turc, G. (2021). European Stroke Organisation (ESO) guidelines on intravenous thrombolysis for acute ischaemic stroke. *European Stroke Journal*, *6*(1), I–LXII. https://doi.org/10.1177/2396987321989865

Butler, K., Anderson, N., & Jull, A. (2023). Evaluating the effects of triage education on triage accuracy within the emergency department: An integrative review. *International Emergency Nursing*, *70*, 101322. https://doi.org/10.1016/j.ienj.2023.101322

Dziewas, R., Michou, E., Trapl-Grundschober, M., Lal, A., Arsava, E. M., Bath, P. M., Clavé, P., Glahn, J., Hamdy, S., Pownall, S., Schindler, A., Walshe, M., Wirth, R., Wright, D., & Verin, E. (2021). European Stroke Organisation and European Society for Swallowing Disorders guideline for the diagnosis and treatment of post-stroke dysphagia. *European Stroke Journal*, *6*(3), LXXXIX–CXV. https://doi.org/10.1177/23969873211039721

Feigin, V. L., Brainin, M., Norrving, B., Martins, S., Sacco, R. L., Hacke, W., Fisher, M., Pandian, J., & Lindsay, P. (2022). World Stroke Organization (WSO): Global stroke fact sheet 2022. *International Journal of Stroke*, *17*(1), 18–29. https://doi.org/10.1177/17474930211065917

Feigin, V. L., Stark, B. A., Johnson, C. O., Roth, G. A., Bisignano, C., Abady, G. G., et al. (2021). Global, regional, and national burden of stroke and its risk factors, 1990–2019: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *The Lancet Neurology*, *20*(10), 795–820. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(21)00252-0

Hilkens, N. A., Casolla, B., Leung, T. W., & de Leeuw, F.-E. (2024). Stroke. *The Lancet*, *403*(10446), 2820–2836. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)00642-1

Hui, C., Tadi, P., Suheb, M. Z. K., & Patti, L. (2024). *Ischemic stroke*. StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499997/

Kleindorfer, D. O., Towfighi, A., Chaturvedi, S., Cockroft, K. M., Gutierrez, J., Lombardi-Hill, D., et al. (2021). 2021 guideline for the prevention of stroke in patients with stroke and transient ischemic attack. *Stroke*, *52*(7), e364–e467. https://doi.org/10.1161/STR.0000000000000375

Saini, V., Guada, L., & Yavagal, D. R. (2021). Global epidemiology of stroke and access to acute ischemic stroke interventions. *Neurology*, *97*(20 Suppl 2), S6–S16. https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000012781

Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar diagnosis keperawatan Indonesia: Definisi dan indikator diagnostik* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar intervensi keperawatan Indonesia: Definisi dan tindakan keperawatan* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2019). *Standar luaran keperawatan Indonesia: Definisi dan kriteria hasil keperawatan* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

Turc, G., Tsivgoulis, G., Audebert, H. J., Boogaarts, H., Bhogal, P., De Marchis, G. M., et al. (2023). European Stroke Organisation (ESO)–European Society for Minimally Invasive Neurological Therapy (ESMINT) guidelines on mechanical thrombectomy in acute ischaemic stroke. *Journal of NeuroInterventional Surgery, 15*(e1), e8. https://doi.org/10.1136/neurintsurg-2021-018589